Historia Clínica — María González

Fecha: 2026-03-28 | **Estado:** Completa | **Extracción IA:** Gemini 2.5 Pro

---

Datos Personales

Campo	Valor
Nombre	María González
Edad	40 años (FN: 1984-03-15)
Ocupación	Contadora en estudio contable (15 años)
Categoría laboral	Administrativa/Profesional
Exposición	Pantalla >10 hs/día, estrés fiscal

Motivo de Consulta

Cefalea crónica

Enfermedad Actual

Paciente femenina de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por cuadro de cefalea de 3 meses de evolución. Refiere episodios de frecuencia casi diaria, con predominio vespertino, que mejoran durante los fines de semana. Describe el dolor como una presión en la región occipital con irradiación a ambas sienes.

La intensidad habitual es de **6-7/10**, alcanzando **8/10** en los episodios más severos, los cuales le impiden la concentración. La duración de los episodios, sin medicación, es de **4-5 horas**. Los episodios de mayor intensidad se asocian a **fotofobia** y **náuseas ocasionales**, sin vómitos. No refiere fonofobia.

Parámetro	Detalle
Cronología	3 meses
Severidad	6-8/10 EVA
Síntomas asociados	Fotofobia (episodios intensos), Náuseas (ocasionales)
Factores agravantes	Pantalla prolongada, Estrés laboral
Factores aliviantes	Descanso (fines de semana), Ibuprofeno
Tratamientos probados	Ibuprofeno 400mg (2-3x/sem), Paracetamol 500mg (ocasional)

Antecedentes Personales

Patológicos

- Hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años, en tratamiento con Enalapril 10mg/día con **adherencia irregular**
- Alergia a Penicilina con **reacción anafiláctica** en la infancia

Fisiológicos

- G1P1 (Cesárea en 2015)
- Ciclos menstruales regulares (cada 28-30 días)

Estilo de vida

- Sedentarismo (sin actividad física)
- Café: 3-4 tazas/día
- Alcohol: social y ocasional
- No tabaquista
- Sueño: 6-7 horas, dificultad ocasional para conciliación

Alergias

> ⚠ **PENICILINA — Anafilaxia confirmada**
>
> Reacción en infancia: rash generalizado, angioedema labial, disnea. Requirió atención de urgencia.
>
> **Grupo:** Beta-lactámicos

Medicación Actual

Medicamento	Dosis	Frecuencia	Adherencia
Enalapril	10mg	1x/día (mañana)	Irregular (olvida fines de semana)
Ibuprofeno	400mg	2-3x/semana	Automedicación
Paracetamol	500mg	Ocasional	Automedicación

Familias: Inhibidor ECA, AINE, Analgésico

Antecedentes Familiares

- **Padre:** Fallecido a los 65 años por infarto agudo de miocardio. Antecedente de HTA.
- **Madre:** Viva, 70 años. Hipertensión arterial en tratamiento.
- **Hermano:** 38 años, sano.
- **Abuela materna:** Diabetes Mellitus tipo 2.

Revisión por Sistemas

Sistema	Hallazgos
Cardiovascular	Niega palpitaciones, disnea y edemas
Respiratorio	Niega tos y disnea
Digestivo	Acidez ocasional asociada al consumo de ibuprofeno
Genitourinario	Niega disuria. Ciclos regulares

Alertas Clínicas

Flags de seguridad identificados por IA:

🛡 **ANTECEDENTE ANAFILAXIA PENICILINA** — Evitar betalactámicos

🛡 **HTA CON ADHERENCIA IRREGULAR** — Evaluar control tensional

🛡 **USO FRECUENTE DE AINES** — Riesgo gastrointestinal y renal

---

Cobertura Semiológica (Argenté)

✅ **Cubiertas adecuadamente:**

- Datos personales
- Motivo de consulta
- Enfermedad actual
- Antecedentes personales
- Antecedentes familiares
- Hábitos y estilo de vida

⚠ **Aún débiles:**

- Interrogatorio neurológico extendido
- Examen físico (limitación del formato digital)

Datos Pendientes para el Médico

- Valores de presión arterial recientes
- Carácter específico del dolor (pulsátil vs opresivo)
- Presencia/ausencia de aura o síntomas neurológicos focales
- Relación de la cefalea con el ciclo menstrual
- Examen neurológico

Nota: Esta historia clínica fue generada a partir de datos provistos por el paciente mediante formulario digital, con extracción y estructuración asistida por IA (Gemini 2.5 Pro, prompt argente_interrogator_v3).

Los datos no reemplazan la evaluación clínica presencial. El profesional tratante debe verificar y completar la información durante la consulta.

AutaMedica — Sistema de Historia Clínica Digital | 2026-03-28